

Кандидоз новорождённых

Кто в группе риска · посевы · флуконазол и микафунгин · профилактика

1. КТО В ГРУППЕ РИСКА

Фактор	Уточнение
Недоношенность	Масса менее 1000 г, гестационный возраст менее 27 недель
Сосудистый доступ	Центральный венозный катетер
Инвазивные устройства	Интубация трахеи, дренажи, катетеры
Антибиотики	Особенно цефалоспорины 3-го поколения и карбапенемы
Питание	Полное парентеральное питание
Хирургия	Операции на органах брюшной полости
НЭК	Течение некротизирующего энтероколита
Препараты	Блокаторы H ₂ -гистаминовых рецепторов
Мать	Кандидозная инфекция во время беременности и родов

2. ГДЕ КАНДИДА ПРЯЧЕТСЯ

Локализация	Чем грозит
Почки	«Грибные шары» на УЗИ, способные вызвать обструкцию
ЦНС	Грибковый менингит: летальность при подтверждённом достигает 50% . В ликворе — белково-клеточная диссоциация: цитоз повышен умеренно, белок высокий
Сердце	Кандидозный эндокардит в 1–10% случаев: чаще митральный и трикуспидальный клапаны, возможны миокард и перикард. На ЭКГ — перегрузка правых отделов
Печень, почки, селезёнка	При кандидемии дольше 5 дней
Кости и суставы	Кандидозный остеомиелит, остеоартрит

При выявлении кандидемии КР требуют **отдельно исключить поражение почек и ЦНС** — это не «по показаниям», а обязательный шаг.

3. ПОСЕВЫ И ПОИСК ОЧАГОВ

Исследование	Как
Кровь на дрожжевые грибы	Не менее 2,0 мл на исследование, 2 раза в сутки 3 дня подряд . У детей ОНМТ и ЭНМТ допускается не менее 1,0 мл — при ОЦК 90 мл/кг больший объём безопасен
Ликвор на грибы	При подозрении на кандидоз ЦНС и перед завершением курса терапии
Материал из других локусов	С определением вида гриба и чувствительности к противогрибковым препаратам
Рентгенография лёгких, УЗИ брюшной полости, почек и надпочечников, НСГ, ЭхоКГ, ЭКГ, офтальмоскопия	Поиск очагов диссеминации — всем при подозрении на инвазивный кандидоз
Биохимия крови	Раз в неделю на фоне терапии: противогрибковые гепато- и нефротоксичны

4. ЛЕЧЕНИЕ

Окно — 12 часов
Стартовая противогрибковая терапия должна быть назначена **не позднее первых 12 часов** от момента выявления *Candida spp.* в посеве крови или материала из стерильного локуса.

Ситуация	Препарат и доза
Подозрение или подтверждённый кандидоз, <i>Candida albicans</i>	Флуконазол 12 мг/кг/сут внутривенно ежедневно
<i>Candida non-albicans</i> или <i>albicans</i>, устойчивая к флуконазолу	Микафунгин 4 мг/кг/сут — стартовая доза
Подозрение на кандидозный менингоэнцефалит или неэффективность стартовой дозы	Микафунгин 10 мг/кг/сут : проникновение в ЦНС дозозависимое

Длительность	14 дней после первого отрицательного посева крови или материала из очага	Катетеры	!! С момента постановки диагноза заменить все: центральные, периферические, пупочные, уретральные, эндотрахеальную трубку и любые дренажи
Коррекция	После получения чувствительности — скорректировать препарат по результату		

5. ПРОФИЛАКТИКА В ОРИТН

Кому	Схема
Всем детям с ЭНМТ, если частота инвазивного кандидоза в отделении выше 2%	Флуконазол 3, 4 или 6 мг/кг/сут внутривенно или внутрь 2 раза в неделю , не более 6 недель
Детям с ЭНМТ при частоте ниже 2% — если есть дополнительные факторы: центральный, периферически вводимый или пупочный катетер, постоянный уретральный катетер, терапия карбапенемами или цефалоспорины 3-го поколения	Та же схема

Профилактика проводится только во время пребывания в ОРИТН и только при наличии факторов риска — это не рутинная мера для всех недоношенных.

6. МЕСТНЫЕ ФОРМЫ

- Врождённый грибковый дерматит встречается редко; исследований по лечению мало, поэтому КР считают целесообразной **системную** противогрибковую терапию.
- Местные противогрибковые препараты применяются по инструкции — клотримазол и другие средства группы D01A.
- Оптимальная длительность терапии дерматита контролируемыми испытаниями не определена.

ИСТОЧНИКИ

— Клинические рекомендации МЗ РФ «Кандидоз новорождённых» — ID 944_1, размещены 16.09.2025.
https://cr.minzdrav.gov.ru/preview-cr/944_1

— Клинические рекомендации МЗ РФ «Сепсис новорождённых» — ID 912_1, размещены 20.05.2025.
https://cr.minzdrav.gov.ru/preview-cr/912_1

— Факторы риска, объём посевов, дозы и схема профилактики приведены по разделам 1, 2, 3 и 5 КР «Кандидоз новорождённых»; алгоритмы диагностики и эмпирической терапии — приложения Б1 и Б2 тех же КР.